目录

1. 创伤后应激障碍 ———————————————————— 2
2. 焦虑症 ———————————————————————— 6
3. 精神分裂症 ———————————————————— 10
4. 物质成瘾 ———————————————————— 13
5. 双相情感障碍 ———————————————— 17
6. 抑郁症 ———————————————————— 21
7. 注意力缺陷与多动障碍 ———————— 24
8. 躯体化症状 ———————————————— 29
9. 强迫症 ———————————————————— 33
10. 性欲倒错 ———————————————— 37
11.特定恐惧症 ———————————————— 43
12.小众疾病分享 ———————————————— 46

1. 创伤后应激障碍 (PTSD)

[病名]

创伤后应激障碍

[俗称]

PTSD

[症状]

情感与心境的多维度负面改变

- 持续的情绪低落（抑郁心境）
- 无法感受快乐（兴趣减退/快感缺失）
- 过度的内疚感与羞耻感

攻击性与对外部化行为

- 易怒、难以控制的愤怒
- 攻击性或对外部化的行为

解离症状

- 感觉与自己的身体或思想分离（不真实感）
- 对创伤经历的记忆出现空白（解离性遗忘）
- 情感麻木

负面的自我与世界认知

- 产生关于自我、他人和世界的持久且夸大的负面评价
- 如"我是有缺陷的"、"这个世界是绝对危险的"

人际敏感与关系困难

- 难以信任他人、与他人疏离
- 人际关系紧张、对人际互动过度敏感

过度的警觉与反应性

- 对威胁信号过度敏感

- 生理上高度唤醒，广泛的生理过度警觉

回避与功能维持

- 持续回避与创伤相关的想法、感受、对话、活动、场所或人物

- 这种行为阻碍了新的适应性学习机会

[具体诊断]

需全部满足以下诊断标准：

1. 创伤事件暴露
   - 直接经历、目睹、获悉亲人或亲密朋友遭遇创伤事件

   - 反复暴露于创伤事件的细节中

2. 侵入性症状（至少 1 项）
   - 反复、不由自主地、闯入性地回忆创伤事件

   - 反复做与创伤事件相关的痛苦梦境

   - 分离性反应（闪回）

   - 接触象征或类似创伤事件提示时产生心理痛苦

   - 对象征或类似提示产生明显的生理反应

3. 持续性回避（至少 1 项）
   - 回避与创伤事件相关的记忆、思想或感觉

   - 回避能够唤起创伤事件记忆的外部提示

4. 认知和情绪的负面改变（至少 2 项）
   - 无法记住创伤事件的重要方面

   - 持续且夸大的负面信念和预期

   - 由于扭曲认知导致责备自己或他人

   - 持续性的负面情绪状态

   - 明显减少对重要活动的兴趣或参与

- 与他人疏远或脱离的感觉

- 持续无法感受积极情绪

5. 警觉性和反应性的显著改变（至少 2 项）
   - 易怒行为或言语/身体攻击

   - 鲁莽或自我毁灭行为

   - 过度警觉、过分的惊跳反应

   - 注意力问题、睡眠障碍

6. 症状持续 1 个月以上
7. 功能损害：引起社交、职业或其他重要功能领域的临床显著痛苦或损害

[一般治疗方式]

心理治疗

- 认知行为疗法：帮助患者识别和改变导致症状的负面思维模式

- 认知加工疗法：针对创伤相关的认知扭曲进行工作

- 暴露疗法：在安全可控环境下逐步接触恐惧源

- 眼动脱敏与再加工治疗：通过眼动运动帮助处理创伤记忆

- 其他心理治疗：冥想-放松疗法、游戏疗法、艺术疗法、太极疗法、瑜伽疗法

药物治疗

- 改善睡眠类药物：针对睡眠障碍

- 抗抑郁类药物：调节情绪和焦虑症状

- 非典型抗精神病药物：用于严重的情绪调节问题

- 抗惊厥类药物：帮助稳定情绪

物理治疗

- 生物反馈：学习控制生理反应

- 经颅磁刺激：非侵入性脑刺激治疗

- 虚拟现实技术：用于暴露治疗

中医治疗
- 中药调理、针灸等传统治疗方法

治疗周期
- 通常需要长期治疗，症状改善是一个渐进过程

- 治疗重点不仅是症状消除，还包括功能恢复和社会再融入

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1：只有内心脆弱的人才会得 PTSD
解释：PTSD 并非性格缺陷或意志薄弱的结果，而是大脑生物学和神经内分泌系统在应对异常巨大压力时发生的可预测改变。创伤事件会"覆盖"大脑正常的恐惧反应、记忆处理和威胁评估系统。研究显示，创伤事件的严重程度、持续时间、类型是比个人"韧性"更重要的风险因素。

误解 2：时间能治愈一切，只需要'走出来'
解释：对于许多 PTSD 患者，创伤记忆并不会自然消退。由于创伤记忆编码和整合的方式存在问题，单纯的时间流逝并不能带来治愈。回避是 PTSD 的核心症状，但这会阻碍情感处理和康复。专业的创伤治疗对于帮助大脑安全地处理和整合创伤记忆至关重要。

[典型病例]

案例背景
特里，42 岁男性，地震幸存者。在八年前的地震中目睹他人受伤和死亡场景。

症状表现
- 主动回避：极力避免回想与地震相关的任何想法，通过疯狂工作填满时间

- 侵入性症状：不请自来的痛苦思绪和画面闯入脑海，每晚做痛苦噩梦

- 认知困扰：形成核心恐惧信念"一旦回想创伤就会情绪失控"

- 功能影响：严重失眠，与妻子分房睡，影响工作和家庭生活

治疗过程
- 接受想象暴露疗法

- 在治疗师安全引导下反复详细口头叙述地震经历

- 描述所有感官细节和当时的思想情绪

- 通过录音在家进行反复练习

治疗结果

- 持续面对记忆而不逃避时，恐惧和焦虑感逐渐减弱
- 成功验证并推翻错误预测，认识到"记忆本身并不危险"
- 能够轻松讨论经历，生活重新回到正轨

[高共病率]

- 抑郁症
- 恐慌症
- 物质使用障碍
- 精神病
- 边缘型人格障碍和慢性疼痛
- 精神分裂症

[相关/易混淆障碍]

复杂性创伤后应激障碍(CPTSD)

- 包含 PTSD 所有核心症状
- 附加三个主要领域的严重功能障碍：
  1. 情感调节问题
  2. 消极的自我概念（深深的羞耻感、无价值感）
  3. 人际关系困难
- 通常与长期、反复、难以逃脱的创伤经历有关（如童年虐待、家庭暴力）

2. 焦虑症

[病名]

焦虑症

[俗称]

紧张症

[症状]

情绪与认知症状

- 持续性的、过度的担忧和恐惧
- 感到不安、紧张或"濒临崩溃"
- 难以集中注意力或头脑一片空白
- 预期性焦虑（对即将发生的事情感到灾难性的恐惧）

躯体症状

- 心悸、心跳加速或心慌
- 出汗、颤抖或发抖
- 呼吸急促或有窒息感
- 胸痛或不适
- 头晕、头昏或感觉不稳
- 恶心或腹部不适
- 肌肉紧张或疼痛
- 疲劳、失眠或睡眠障碍

[具体诊断]

以广泛性焦虑障碍为例（DSM-5 标准）
需满足以下全部条件：

A. 过度焦虑和担忧

- 在至少 6 个月的时间里，对许多事件或活动表现出过度的焦虑和担忧

B. 控制困难

- 难以控制这种担忧

C. 伴随症状（至少 3 项）

1. 坐立不安或感到紧张
2. 容易疲劳
3. 注意力难以集中或头脑空白

4. 易怒
5. 肌肉紧张
6. 睡眠障碍（儿童只需一项）

D. 功能损害
• 症状引起具有临床意义的痛苦，或导致社交、职业等重要功能损害

E. 排除其他原因
• 症状不能归因于某种物质或其它医学状况

F. 排除其他障碍
• 症状不能用其他精神障碍更好地解释

[一般治疗方式]

心理治疗
• 认知行为疗法(CBT)：帮助患者识别和改变导致焦虑的负面思维模式和行为

• 暴露疗法：针对恐惧症和惊恐障碍，在安全可控的环境下逐步接触恐惧源

药物治疗
• 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)：如舍曲林、艾司西酞普兰（一线选择）

• 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)：如文拉法辛

• 苯二氮草类药物：如阿普唑仑、劳拉西泮（用于短期缓解急性焦虑，需谨慎使用）

• 其他药物：丁螺环酮、普瑞巴林等

治疗原则
• 个体化治疗方案

• 长期维持治疗预防复发

• 结合生活方式调整和心理教育

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1："焦虑症就是想太多，放松一下就好了"
解释：焦虑症是一种具有神经生物学基础的医学疾病，涉及大脑中神经递质（如 5-羟色胺、去甲肾上腺素）的功能失调。它不是个人意志力薄弱或性格缺陷，患者无法仅通过"放松"或"停止担忧"来克服。

误解 2："只有胆小或脆弱的人才会得焦虑症"

解释：焦虑症可以影响任何人，无论其性格、性别或背景。它是遗传、环境、心理和神经生物因素复杂相互作用的结果。

[典型病例]

病史摘要

- 患儿，女性，9 岁
- 2021 年 4 月发病，8 月后出现频繁眨眼，半个月后出现喉部发声
- 辗转多家医院诊断不一，治疗未见明显进展

症状体征

- 慢性起病，以"胡言乱语"为主要临床表现
- 不能上学及与人正常交流，功能明显受损

诊断方法

- 根据 ICD-10 诊断标准：F41.9 焦虑障碍，未特定

治疗方法

- 予以氟伏沙明 50mg/d 治疗 18 天

临床转归

- 患者的言语及情绪较前缓解
- 出院后逐渐能恢复上学，回归正常生活

[高共病率]

- 抑郁症：约 50%-60%的焦虑症患者会同时经历抑郁症
- 其他焦虑障碍：广泛性焦虑障碍与惊恐障碍的共病率很高
- 物质使用障碍：约 20%-30%的焦虑症患者存在酒精或药物使用问题
- 双向情感障碍：约 71.1%的双向情感障碍 I 型患者和 86.6%的 II 型患者会共病焦虑障碍
- 躯体症状障碍：广泛性焦虑障碍患者中约 39.0%会共病躯体形式障碍

[相关/易混淆障碍]

- 抑郁症：情绪低落、兴趣丧失是核心，但常与焦虑共存

- 强迫症(OCD)：以侵入性思维和重复行为为特征
- 创伤后应激障碍(PTSD)：由创伤事件引发，包含再体验、回避和高警觉症状
- 躯体形式障碍：关注躯体症状本身，但可能由潜在焦虑驱动
- 甲状腺功能亢进：医学状况，症状与焦虑症相似，需医学鉴别

3. 精神分裂症

[病名]

精神分裂症

[俗称]

精分

[症状]

阳性症状
- 持续的妄想：夸大妄想、关系妄想、被害妄想
- 持续的幻觉：任何形式的幻觉，最常见的是幻听
- 思维紊乱：词不达意、思维松弛、言语不连贯、语词新作
- 被动体验：感觉、动机行为或思想被他人强加

阴性症状
- 情感平淡、思维贫乏或言语贫乏
- 意志缺乏、社交缺乏或兴趣缺失

行为症状
- 明显的行为紊乱：怪异或无目的的行为
- 精神运动性症状：紧张症性不安、作态、蜡样屈曲

认知症状
- 注意力问题、执行功能损害
- 工作记忆和学习能力下降

[具体诊断]

ICD-11 诊断标准
首次发作者通常要求在一个月及以上时期的大部分时间内持续存在上述症状条目中至少 2 项，且其中至少符合核心症状中的 1 项

诊断要点
1. 症状必须持续存在相当长时间
2. 导致个人、家庭、社交、教育、职业或其他重要功能领域明显损害
3. 不能归因于其他精神障碍或物质使用

[一般治疗方式]

药物治疗
- 第一代抗精神病药：氯丙嗪、氟哌啶醇、奋乃静
  - 主要阻断多巴胺 D2 受体，对阳性症状疗效较好
  - 易引起锥体外系反应，长期使用可能导致运动异常
- 第二代抗精神病药：利培酮、奥氮平、喹硫平、阿立哌唑
  - 作用于多巴胺和 5-羟色胺系统，对阳性和阴性症状均有效
  - 不良反应相对较少，但可能引发代谢综合征

物理治疗
- 电抽搐治疗(ECT)：对急性发作患者疗效与药物相当
- 重复经颅磁刺激：有前景的治疗方法，需更多临床验证
- 深部脑刺激：研究中的治疗方法

心理与社会干预
- 社会技能训练：改善社交功能
- 家庭干预：提高家庭支持质量
- 认知行为疗法：帮助应对症状
- 社区服务：促进社会再融入

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1：精神分裂症="人格分裂"或"多重人格"
解释：精神分裂症在医学上并非人格的分裂，而是思维、情感、感知和行为之间统一性的分裂。患者的感知和思维过程出现了混乱，但"人格"通常仍然是一个。不是一个人分裂成好几个人，而是思维、感知和现实感出现了混乱。

误解 2：精神分裂症患者都是危险的、有暴力倾向的
解释：绝大多数患者并没有暴力倾向。研究反复表明，他们更可能是暴力的受害者。相比于对他人造成伤害，他们因疾病而自伤、自杀的风险要高得多。极少数情况下可能出现激动或暴力行为，这通常发生在急性发病期，并且是疾病症状驱动的。

[典型病例]

病例背景
患者，女性，24 岁，因"喜好同性 1 年，行为反常、易激惹 6 个月"就诊

临床表现
- 大学毕业后拒绝外出找工作，整日沉迷网络与同性聊天
- 逐渐变得懒散少动、闭门不出
- 对家人劝阻置若罔闻，有时自言自语、发笑
- 对待家人如同陌生人，稍不顺心就发脾气

诊断过程
- 精神检查发现警惕性高、易激惹
- 存在钟情妄想、评论性幻听、关系妄想
- 自知力缺乏，长期不工作找借口
- 心理测量显示病情中度严重

治疗过程
- 选用奥氮平治疗，起始剂量 5mg/d，逐渐增至 15mg/d
- 结合支持性心理治疗和认知行为治疗
- 治疗期间密切监测病情和不良反应

治疗结果
- 症状显著改善，情感、思维、认知功能恢复正常

- 对同性恋看法改变，成为教师，正常工作学习

- 坚持服药 1 年后逐步减量

[高共病率]

- 焦虑障碍

- 物质使用障碍

[相关/易混淆障碍]

- 双相情感障碍：需要鉴别情绪高涨和低落交替出现的特征

- 妄想性障碍：妄想内容相对固定、系统，一般不伴有幻觉

- 性指向障碍：仅性吸引对象偏好异常，无精神病性症状

4. 物质成瘾

[病名]

物质成瘾

[俗称]

物质使用障碍

[症状]

核心特征

- 无法控制地使用合法物质（如酒精、烟草、咖啡因）或非法物质（如大麻、冰毒、海洛因）

- 物质摄入失控、强烈渴求及负向戒断症状

- 物质使用过程会不断地经历循环，每次循环都包含：

  1. 摄入物质阶段
  2. 负向戒断症状阶段
  3. 期待渴求阶段

具体表现

- 失控使用：摄入量或使用时间超出预期

- 时间消耗：大量时间用于获取、使用或从物质效应中恢复

- 渴求：强烈的使用欲望或冲动

- 功能损害：无法履行工作、学习或家庭中的主要责任

- 社交问题：因使用而放弃或减少重要社交、职业或娱乐活动

- 风险使用：在身体危险情况下仍坚持使用

- 耐受性：需要增加剂量才能达到预期效果

- 戒断症状：停止或减少使用时出现生理和心理不适

[具体诊断]

ICD-11 诊断标准
在过去 12 个月中反复出现或者在既往 1 个月中持续出现下述 3 条核心症状中的至少 2 条：

1. 控制能力受损

- 对物质使用行为难以控制，通常伴有主观强烈的渴求感

- 对使用某种物质的控制能力受损（指开始或停止使用该物质，以及使用该物质的量及使用环境等各方面的控制力都受到损害）

2. 优先地位

- 物质使用在日常生活中处于优先地位，超过其他兴趣爱好、日常活动、自身责任、健康以及自我照顾等

- 即使已经有不良后果出现，依旧坚持使用成瘾物质

3. 生理特征

- 耐受性：需要增加剂量才能达到预期效果

- 戒断症状：停止或减少使用后出现生理和心理不适

- 再次使用：使用原来物质（或者药理作用相似的物质）可以避免或减轻戒断症状

严重程度分级

- 轻度：存在 2-3 个症状

- 中度：存在 4-5 个症状

- 重度：存在 6 个或以上症状

[一般治疗方式]

药物治疗

- 酒精成瘾治疗
  - 急性中毒治疗：催吐、洗胃，生命体征维持
  - 戒断症状治疗：通过降低谷氨酸活性或增加 GABA 活性来阻止失控的兴奋
  - 预防复发治疗：戒酒硫、纳曲酮
  - 心理社会干预：动机强化治疗、正念防复发治疗、认知行为疗法
- 尼古丁成瘾治疗
  - 药物治疗：尼古丁替代疗法(NRT)、安非他酮(缓释剂)、可乐定、疫苗疗法、伐尼克兰
  - 心理治疗：心理教育干预、行为技巧训练和认知行为干预
  - 中医中药治疗：中草药、针灸、气功等在戒烟治疗中应用很广

心理治疗

- 认知行为疗法：帮助患者识别和改变导致物质使用的负面思维模式和行为
- 动机性访谈：增强患者改变的内在动机
- 应急管理：通过正强化来鼓励戒断
- 家庭治疗：改善家庭支持系统和沟通方式

康复计划

- detox 阶段：安全度过戒断期
- 康复阶段：学习应对技巧和预防复发策略
- 维持阶段：长期坚持康复计划，防止复发

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1："物质成瘾戒不掉是因为自律性不强"
解释：世界卫生组织(WHO)和美国医学会(AMA)等权威机构早已将成瘾定义为一种复杂的慢性复发性脑部疾病。成瘾与遗传、环境(如童年创伤、社会压力)、心理健康(如抑郁、焦虑)

以及初次使用年龄等多种因素密切相关。大脑中负责决策、判断和自我控制的前额叶皮层功能会因此受损。这意味着，成瘾者并非"不想"停下来，而是他们的大脑功能发生了改变，"不能"靠单纯的自律来停止。

误解 2："认为只要完成了生理脱毒，身体不再有戒断反应，问题就解决了"
解释：生理脱毒只是康复的第一步，也是最简单的一步。真正的挑战在于长期的"心理依赖"和"行为改变"。即使身体没有戒断反应，大脑对药物的强烈心理渴求(心瘾)会持续数月甚至数年，在特定环境、情绪或人际关系的触发下，极易复发。成瘾者需要学习新的应对压力、管理情绪和解决问题的技能，以替代之前用药物来应对的方式。这需要长期的心理治疗、行为矫正和社会支持。

[典型病例]

临床资料
患者，男性，38 岁，因"截瘫后下肢疼痛 9 年，强制性觅药行为 8 年，情绪差、自杀未遂 6 年"入院。

病史特点
1. 截瘫与疼痛：2014 年 4 月工伤致下半身截瘫，术后出现脊髓损伤平面以下部位的持续性刀割及灼烧样疼痛
2. 药物使用历程：
   - 2014-2016 年：开始服用氨酚羟考酮片、酒石酸唑吡坦，逐渐自行加大药量
   - 2016 年后：氨酚羟考酮片加量至 17 片/d，酒石酸唑吡坦 20-30mg/d
   - 2018 年：药物用量进一步增加，出现情绪低落、悲观消极
   - 2020 年：出现自杀行为，开始加用氯硝西泮
3. 戒断症状：2020 年及 2021 年两次停用酒石酸唑吡坦后出现烦躁焦虑、意识丧失、四肢抽搐

治疗过程
1. 镇痛及抗抑郁治疗：文拉法辛联合普瑞巴林
2. 脱瘾治疗：按照先快后慢策略逐渐递减氯硝西泮
3. 对症治疗：左甲状腺素钠片、保肝药物、叶酸片

治疗结果
住院治疗 3 个月后疼痛程度减轻，未再有情绪差、生活没有意思等抑郁体验，与周围病友相处好，积极配合病房康复活动。

[高共病率]

- 抑郁症：约 50%-60%的成瘾患者会同时经历抑郁症

- 焦虑障碍：广泛性焦虑障碍与物质使用障碍的共病率很高
- 创伤后应激障碍(PTSD)：约 20%-30%的 PTSD 患者存在物质使用问题
- 注意缺陷/多动障碍(ADHD)：成人 ADHD 中物质使用障碍发生率较高
- 精神分裂症：精神分裂症患者中物质使用障碍较为常见

[相关/易混淆障碍]

- 抑郁症：情绪低落、兴趣丧失是核心，但常与物质使用共存
- 双相情感障碍：情绪高涨和低落交替出现，可能通过物质使用来自我治疗
- 创伤后应激障碍：由创伤事件引发，可能通过物质使用来缓解症状
- 注意缺陷/多动障碍：冲动控制问题可能导致物质使用
- 人格障碍：特别是边缘型人格障碍和反社会型人格障碍

5. 双相情感障碍

[病名]

双相情感障碍

[俗称]

躁郁症、双相障碍

[症状]

躁狂/轻躁狂发作症状

- 情绪症状：情绪异常高涨、精力旺盛、活动增加
- 认知症状：过度自信(夸大妄想)、思维奔逸、注意力分散
- 行为症状：对睡眠的需求量大量减少、有鲁莽或冒险行为
- 其他症状：易激惹、攻击性或冲动失控行为

抑郁发作症状

- 情绪症状：持续性悲伤、丧失兴趣、自我价值感低下

- 认知症状：思维迟钝、记忆衰退、决策困难

- 行为症状：动作迟缓、社交退缩、睡眠障碍

- 躯体症状：食欲改变、体重变化、疲劳乏力

混合状态
- 同时出现躁狂和抑郁症状

- 情绪不稳定，易激惹

- 思维混乱，行为冲动

[具体诊断]

DSM-5 诊断标准
双相 I 型障碍
- 有至少 1 次躁狂发作

- 可能有重性抑郁发作，但不是诊断必需

双相 II 型障碍
- 至少有 1 次轻躁狂发作

- 至少有 1 次重性抑郁发作

- 从无躁狂发作

环性心境障碍
- 多次轻躁狂症状和抑郁症状

- 症状未达到重性抑郁或躁狂发作标准

- 症状持续至少 2 年（儿童和青少年 1 年）

[一般治疗方式]

药物治疗
- 心境稳定剂：锂盐、丙戊酸盐、卡马西平

- 非典型抗精神病药：奥氮平、喹硫平、利培酮、阿立哌唑

• 抗抑郁药物：SSRIs、SNRIs（需谨慎使用，可能诱发转躁）

心理治疗
• 认知行为疗法：帮助患者识别和应对情绪波动

• 家庭聚焦疗法：改善家庭沟通和支持系统

• 人际与社会节律疗法：帮助建立规律的生活作息

• 心理教育：帮助患者和家属了解疾病和管理策略

其他治疗
• 电抽搐治疗(ECT)：对严重或难治性病例有效

• 重复经颅磁刺激(rTMS)：对抑郁症状有帮助

• 光照疗法：对季节性模式的患者有效

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1："情绪波动大就是双相障碍"
解释：每个人都有情绪起伏，但双相障碍的情绪波动是极端的、持续性的，并且严重影响到日常生活功能。诊断需要符合特定的症状标准和持续时间，不是简单的"情绪不稳定"。

误解 2："双相障碍就是一会儿高兴一会儿难过"
解释：双相障碍的躁狂/轻躁狂发作不仅仅是"高兴"，而是包含了一系列认知、行为和生理改变的综合状态。抑郁发作也不仅仅是"难过"，而是深度的情感、认知和生理功能的全面抑制。

误解 3："药物会让人变得麻木"
解释：恰当的治疗不会让患者变得麻木，而是帮助恢复情绪的稳定性和调节能力。未经治疗的双相障碍反而会导致情感体验的极端化和功能损害。

[典型病例]

病例背景
方某，女性，14 岁，因"复发情绪低落 2 年，加重 1 月"就诊

临床表现
• 现病史：情绪低落，刻板行为，喜过度消费，厌学，一提学校易诱发，偶自残，有自杀念头

• 既往史：胃炎？否认药物过敏史

- 个人史：头胎，顺产，学习成绩优秀

- 家族史：否认精神疾病遗传史

诊断过程

- 体格检查：BP 120/80mmHg，舌质红，苔薄白，脉细

- 精神检查：意识清，定向力完整，易激惹，自知力缺乏

- 量表评估：汉密尔顿抑郁量表 31 分，汉密尔顿焦虑量表 19 分

- 专科诊断：抑郁症伴双相情感障碍，当前低度自杀风险

治疗过程

- 中药治疗：宁神温胆汤加减，舒肝解郁胶囊

- 西药治疗：舍曲林加九味镇心颗粒

- 心理治疗：支持性心理治疗，认知行为治疗

治疗结果

累计治疗半年后病情稳定，情绪极大改善，愿意去学校，社会功能恢复

[高共病率]

- 焦虑障碍：共病率 40.5%

- 注意缺陷/多动障碍：共病率 17.1%

- 物质使用障碍：约 30-50%

- 边缘型人格障碍：约 10-20%

- 强迫症：约 10-20%

[相关/易混淆障碍]

- 重性抑郁障碍：只有抑郁发作，无躁狂/轻躁狂发作

- 注意缺陷/多动障碍：冲动和多动症状可能与轻躁狂相似

- 边缘型人格障碍：情绪不稳定和冲动行为可能相似

- 精神分裂症：可能出现类似躁狂的精神病性症状

• 物质所致心境障碍：物质使用可能导致类似症状

6. 抑郁症

[病名]

抑郁症

[俗称]

忧郁症、临床抑郁症

[症状]

核心症状

• 情绪低落：持续性的悲伤、空虚感或无望感

• 兴趣丧失：对以往感兴趣的活动失去兴趣或快感缺失

• 精力减退：疲劳或精力丧失，即使休息后也难以恢复

心理症状

• 无价值感：过度或不适当的内疚感、自我贬低

• 注意力障碍：难以集中注意力、决策困难

• 死亡念头：反复出现死亡念头、自杀意念或自杀行为

躯体症状

• 睡眠障碍：失眠（难以入睡、早醒）或嗜睡

• 食欲改变：食欲减退或增加，伴有相应的体重变化

• 精神运动性改变：激越（坐立不安）或迟滞（动作缓慢）

• 躯体不适：头痛、背痛、消化问题等无法用医学解释的身体症状

[具体诊断]

DSM-5 诊断标准
需满足以下全部条件：

A. 症状标准
在连续两周内，出现 5 个或以上下述症状，其中必须包括：
1. 情绪低落和/或
2. 兴趣或快感丧失

其他症状包括：
3. 显著的体重变化或食欲改变
4. 失眠或嗜睡
5. 精神运动性激越或迟滞
6. 疲劳或精力丧失
7. 无价值感或过度内疚
8. 思考能力减退或注意力不集中
9. 反复出现死亡念头

B. 功能损害
症状引起具有临床意义的痛苦，或导致社交、职业或其他重要功能损害

C. 排除标准
症状不能归因于某种物质或其他医学状况
排除其他精神障碍如双相情感障碍等

[一般治疗方式]

心理治疗
- 认知行为疗法(CBT)：识别和改变负面思维模式和行为
- 人际心理治疗(IPT)：改善人际关系和社交功能
- 行为激活：增加积极活动和成就感
- 正念疗法：培养对当下体验的非判断性意识

药物治疗
- 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)：
  - 氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、西酞普兰、艾司西酞普兰
  - 一线选择，相对安全，副作用较少
- 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)：
  - 文拉法辛、度洛西汀
  - 对伴有疼痛症状的抑郁更有效

- 其他抗抑郁药：
  - 米氮平、安非他酮、阿戈美拉汀
  - 根据不同症状特点选择

物理治疗
- 电休克治疗(MECT)：用于难治性或重症患者
- 重复经颅磁刺激(rTMS)：非侵入性脑刺激治疗
- 光照疗法：对季节性抑郁有效

综合治疗
- 药物治疗与心理治疗结合
- 家庭支持和社会康复训练
- 定期随访和复发预防

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1："抑郁症只是心情不好，想开点就好了"
解释：抑郁症是一种复杂的生物心理社会疾病，涉及脑内神经递质失调、遗传与环境因素交互作用。它不是单纯的心态问题或意志力薄弱，而是需要专业治疗的医学疾病。

误解 2："抑郁症患者都是软弱或不坚强的人"
解释：抑郁症与个人性格坚强与否无关。任何人都可能患病，是遗传、生物、心理和社会因素复杂相互作用的结果。患者需要的是理解和专业帮助，而不是批评指责。

误解 3："吃药会成瘾，而且改变人格"
解释：抗抑郁药不会成瘾，其作用是调节脑内化学物质平衡。通常需要持续服用数月至数年，并在医生指导下调整。正规治疗不会改变人格，而是帮助恢复正常功能。

[典型病例]

病史摘要
患者，女性，14 岁，心情差 3 年，加重伴自杀自伤 3 个月入院

症状表现
- 情绪低落，注意力难集中，思维迟缓
- 自卑自责，反复划手、撞头，自杀意念强烈

- 伴疲乏嗜睡、长期人际关系敏感

- 正性事件可见短暂愉悦的情绪反应

诊断治疗
- 诊断：抑郁症伴混合性特征

- 治疗：药物联合 12 次 MECT 治疗

- 辅助：支持性治疗、行为管理、心理治疗

临床转归
情感低落症状改善，认识到与父母的不良互动模式，自伤自杀得到控制

[高共病率]

- 焦虑障碍：约 50-60%

- 物质使用障碍：约 20-30%

- 人格障碍：边缘型人格障碍约 20-40%

- 躯体疾病：心血管疾病约 15-30%，糖尿病约 10-15%

[相关/易混淆障碍]

- 双相情感障碍：需鉴别是否有躁狂/轻躁狂发作

- 适应障碍：对明确应激源的反应，症状较轻

- 躯体形式障碍：关注躯体症状而非情绪症状

- 注意缺陷/多动障碍：可能共病或症状相似

- 创伤后应激障碍：有明确的创伤史和特征性症状

7. 注意缺陷多动障碍 (ADHD)

[病名]

注意缺陷多动障碍

[俗称]

ADHD、多动症

[症状]

注意力不集中症状

- 难以保持专注，容易被外界干扰
- 粗心大意，经常犯粗心错误
- 对其说话心不在焉，似乎没在听
- 难以按照指示完成任务，经常半途而废
- 组织任务和活动困难
- 回避需要持续脑力劳动的任务
- 经常丢失任务或活动所需的物品
- 容易被外界刺激分心
- 日常活动中健忘

多动症状

- 手脚经常不安地扭动或在座位上扭动
- 在需要保持坐姿的场合离开座位
- 在不适当的场合跑来跑去或攀爬
- 难以安静地玩耍或从事休闲活动
- 经常"忙个不停"，好像"被马达驱动"
- 说话过多

冲动症状

- 在问题还没问完时就抢着回答
- 难以等待轮到自己
- 经常打断或侵扰他人

核心特征

- 症状出现在两个或更多场合（如家庭、学校、工作）
- 症状持续至少 6 个月
- 症状导致社会、学业或职业功能损害
- 症状在 12 岁前就已出现

[具体诊断]

DSM-5 诊断标准
需满足以下条件：

A. 注意力不集中或多动/冲动模式

- 注意力不集中：9 个症状中至少符合 6 个（17 岁以上需 5 个）
- 多动/冲动：9 个症状中至少符合 6 个（17 岁以上需 5 个）

B. 症状表现

- 症状在 12 岁前就已存在
- 症状出现在两个或更多场合
- 症状干扰或降低社交、学业或职业功能质量
- 症状不能用其他精神障碍更好地解释

严重程度分级

- 轻度：症状轻微，功能损害最小
- 中度：症状或功能损害介于轻度和重度之间
- 重度：症状众多或功能损害显著

[一般治疗方式]

药物治疗

- 中枢兴奋剂
  - 哌甲酯（利他林、专注达）
  - 安非他明（阿德拉尔、维万斯）

  - 作用：增加多巴胺和去甲肾上腺素水平

- 非兴奋剂
  - 托莫西汀（择思达）
  - 胍法辛（Intuniv）
  - 可乐定（Kapvay）
  - 优点：无滥用潜力，作用时间更长

行为治疗
- 家长培训：教授行为管理技巧
- 教室管理：教师使用行为干预策略
- 同伴干预：改善社交技能
- 组织技能培训：提高任务完成能力

教育干预
- 个性化教育计划（IEP）
- 504 计划（ accommodations）
- 学习策略和技能培训

生活方式干预
- 规律作息和睡眠
- 健康饮食和运动
- 限制屏幕时间

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1："ADHD 不是真实疾病，只是孩子不听话"
解释：ADHD 是一种有明确神经生物学基础的神经发育障碍。脑影像学研究显示 ADHD 患者的大脑在结构、功能和连接方面存在差异，特别是在前额叶皮层、基底节和小脑区域。这些大脑区域的差异影响了执行功能、注意力和冲动控制。

误解 2："孩子长大后 ADHD 就会自然消失"

解释：虽然症状可能随年龄变化，但约 60-70%的儿童期 ADHD 患者到成年期仍会经历显著症状。成人 ADHD 可能表现为不同的形式，如时间管理困难、组织能力差、冲动决策等，但仍会对工作、关系和日常生活产生重大影响。

误解 3："药物治疗会让孩子变成僵尸"
解释：恰当剂量的 ADHD 药物不会让孩子变得呆滞或无精打采。相反，它们通过改善大脑中神经递质的平衡来帮助增强注意力、减少冲动和过度活动。当药物类型和剂量正确时，孩子应该看起来更加专注和能够控制自己的行为，而不是被"镇静"。

[典型病例]

病例背景
小明，8 岁男孩，二年级学生

症状表现
- 在学校：难以安坐，经常离开座位；打扰同学上课；作业马虎，经常丢失文具
- 在家里：难以完成作业；房间杂乱无章；经常打断父母谈话
- 社交方面：难以与同伴相处；游戏时不能等待轮换

诊断过程
- 教师完成 Conners 教师评定量表
- 父母完成 ADHD 评定量表和发育史问卷
- 临床医生直接观察和行为评估
- 排除听力、视力问题和其他医学状况

治疗方案
- 药物治疗：哌甲酯缓释片 18mg 每天早晨
- 行为治疗：家长培训+教室行为管理计划
- 教育支持：座位安排靠近教师；额外时间完成作业；定期休息

治疗结果
6 个月后，教师报告注意力显著改善，能够安坐完成作业；父母表示家庭作业时间减少，冲突减少；小明自我报告"感觉更能控制自己"

[高共病率]

- 学习障碍：20-30%

- 对立违抗性障碍：30-50%
- 品行障碍：20-30%
- 焦虑障碍：25-35%
- 抑郁障碍：20-30%
- 抽动障碍：10-20%

[相关/易混淆障碍]

- 焦虑障碍：焦虑可能导致坐立不安和注意力困难，但通常伴有担忧和恐惧
- 抑郁症：可能表现为注意力不集中，但伴有情绪低落和兴趣丧失
- 自闭症谱系障碍：可能有注意力问题，但核心是社交沟通缺陷和重复行为
- 学习障碍：学业困难可能导致挫折感和行为问题
- 躁狂发作：可能有多动和冲动，但伴有情绪高涨和睡眠需求减少

8. 躯体化障碍

[病名]

躯体化障碍

[俗称]

"心理问题的身体表达"、"情绪的身体症状"

[症状]

躯体症状

- 疼痛症状：头痛、背痛、关节痛、腹痛等
- 胃肠道症状：恶心、呕吐、腹胀、腹泻等
- 假性神经症状：吞咽困难、失音、失明等
- 心血管症状：心悸、胸痛等

- 泌尿生殖症状：尿频、排尿困难等

- 皮肤症状：瘙痒、烧灼感、麻木感等

心理特征
- 对身体健康过度关注和担忧

- 反复就医和要求进行检查

- 对阴性检查结果不相信或不满意

- 症状描述夸张和情绪化

- 可能存在"述情障碍"（难以识别和描述情绪）

病程特征
- 症状持续多年

- 症状经常变化

- 涉及多个器官系统

- 导致显著的功能损害

[具体诊断]

DSM-5 诊断标准
躯体症状障碍
1. 一个或多个令人痛苦的躯体症状
2. 与症状相关的过度 thoughts、feelings 或 behaviors，表现为：
    - 持续关注症状的严重性

    - 有关健康或症状的高水平焦虑

    - 过多的时间和精力投入到这些症状或健康关注中

3. 虽然任何一个躯体症状可能不会持续存在，但有症状的状态是持续存在的（通常超过 6 个月）

严重程度分级
- 轻度：仅符合一条标准 B 的特征

- 中度：符合两条或更多标准 B 的特征

• 重度：符合两条或更多标准 B 的特征，且有多重躯体抱怨

[一般治疗方式]

建立治疗关系

• 定期就诊（如每月一次）

• 避免不必要的检查和手术

• 关注功能改善而非症状消除

心理治疗

• 认知行为疗法：识别和改变灾难化思维

• 正念训练：培养对症状的非判断性觉察

• 应激管理：学习应对技巧和放松训练

药物治疗

• 抗抑郁药：SSRIs/SNRIs（改善疼痛感知和焦虑）

• 小剂量抗精神病药：用于难治性病例

其他治疗

• 物理治疗：针对功能性运动障碍

• 作业治疗：改善日常功能

• 团体治疗：提供支持和减少孤立感

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1："症状都是想象出来的"
解释：躯体化障碍患者的痛苦是真实存在的。功能磁共振成像研究显示，这些患者在处理身体感觉和疼痛时的大脑活动模式确实与健康人不同。症状的产生涉及复杂的脑-体相互作用，其中心理压力通过神经内分泌和免疫途径影响了身体感觉的处理和解释。

误解 2："患者能够控制这些症状"
解释：大多数患者并非有意产生或维持这些症状。很多时候，他们对自己的状况感到困惑和沮丧，特别是当医学检查不能提供明确解释时。症状往往是潜意识心理过程的表现，而不是有意识的伪装或操纵。

误解 3："更多的医学检查总能找到病因"

解释：反复寻求医学检查和专家意见（"doctor shopping"）往往是障碍的一部分，而不是解决方案。这种方法可能强化患者的疾病信念，导致更多的无效治疗和潜在的医源性损害。治疗的重点应该是管理症状和改善功能，而不是寻找 elusive 的"真正"医学原因。

[典型病例]

病例背景
张女士，45 岁，已婚，办公室职员

症状历程
- 5 年前：开始出现游走性疼痛（头、背、关节）
- 3 年前：添加胃肠道症状（恶心、腹胀）
- 1 年前：出现心悸和呼吸困难
- 就诊经历：看过神经科、消化科、心内科、风湿科
- 检查结果：全部检查均未发现器质性病变

心理社会因素
- 工作压力大，长期加班
- 婚姻关系紧张
- 父亲有类似"多病" history

治疗过程
- 建立固定的医患关系（每月就诊）
- 开始小剂量 SSRI 治疗
- 接受认知行为治疗
- 学习放松技巧和应激管理

治疗结果
6 个月后，就诊频率减少，对症状的关注度降低，逐渐恢复部分工作功能

[高共病率]

- 抑郁障碍：50-70%
- 焦虑障碍：30-50%

- 其他躯体形式障碍：常见共病
- 人格障碍：特别是依赖型和边缘型

[相关/易混淆障碍]

- 疾病焦虑障碍：关注点是害怕患病而非症状本身
- 转换障碍：表现为神经系统症状（如瘫痪、失明）
- 做作性障碍：有意生产或伪装症状
- 诈病：有明确的外部奖励
- 真正的医学疾病：需要仔细排除

9. 强迫症 (OCD)

[病名]

强迫症

[俗称]

洁癖、强迫症

[症状]

强迫思维

- 反复、持续、不想要且侵入性的想法、影像、冲动
- 常见主题：污染、伤害、对称、禁忌想法
- 引发显著的焦虑或痛苦

强迫行为

- 重复性行为或心理活动
- 为了回应强迫思维或遵循某些规则
- 常见形式：清洗、检查、计数、重复

洞察力水平

- 良好洞察力：认识到信念可能不真实
- 差洞察力：认为信念可能是真实的
- 缺乏洞察力/妄想信念：完全确信信念是真实的

相关特征

- 回避触发情境
- 决策困难
- 过度责任感
- 完美主义

[具体诊断]

DSM-5 诊断标准

1. 存在强迫思维和/或强迫行为
2. 强迫思维或行为是耗时的（每天 1 小时以上）或引起临床显著痛苦
3. 症状不能归因于物质或其他医学状况
4. 障碍不能用其他精神障碍症状更好地解释

标注

- 伴良好或尚可的洞察力
- 伴差的洞察力
- 伴缺乏洞察力/妄想信念
- 抽动相关

[一般治疗方式]

一线治疗

- 认知行为疗法（CBT）：特别是暴露与反应预防（ERP）
- 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）：
  - 氟西汀、氟伏沙明、舍曲林、帕罗西汀
  - 通常需要较高剂量和较长起效时间（12 周）

二线治疗

- 氯米帕明：三环类抗抑郁药，SSRI 无效时考虑

- 增强策略：SSRI+抗精神病药（利培酮、阿立哌唑）

难治性 OCD 治疗

- 深部脑刺激（DBS）

- 神经外科手术：囊切开术、扣带回切开术

新治疗方法

- 谷氨酸调节剂：美金刚、利鲁唑

- 免疫调节治疗：针对 PANDAS/PANS

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1："强迫症只是喜欢整洁和有序"
解释：虽然媒体经常将 OCD 描绘为对清洁和组织的过度关注，但真实的 OCD 要复杂和痛苦得多。强迫思维可以涉及任何主题，包括暴力、性或宗教内容。许多强迫行为是内在的心理仪式，从外部根本看不出来。障碍的核心是这些想法和行为带来的巨大痛苦和功能损害，而不是简单的"偏好"或"习惯"。

误解 2："患者只要'放松'或'停止思考'就能克服"
解释：OCD 的症状具有生物学基础，涉及大脑回路（特别是皮质-纹状体-丘脑-皮质回路）的功能异常。告诉 OCD 患者"停止思考"强迫思维就像告诉哮喘患者"记得呼吸"一样无效。专业的治疗，特别是暴露与反应预防（ERP），是通过帮助大脑重新学习反应方式来工作，而不是通过简单的意志力。

误解 3："所有重复行为都是强迫症"
解释：很多人都有小习惯或偏好，比如以特定方式安排桌面或避免踩裂缝。这些只有在它们消耗大量时间（每天超过 1 小时），引起显著痛苦，或干扰日常生活时才成为 OCD。关键的区别在于这些行为是 ego-dystonic（与自我意识冲突）还是 ego-syntonic（与自我意识一致）。

[典型病例]

病例背景

李先生，32 岁，软件工程师

症状表现

- 强迫思维：害怕污染和伤害家人

- 强迫行为：

    - 每天洗手 50+次，导致皮肤破损
    - 检查煤气阀门 2 小时/天
    - 重复祈祷直到"感觉正确"
- 功能影响：上班经常迟到，回避社交活动

治疗过程

- 药物治疗：舍曲林 200mg/天
- 行为治疗：ERP 治疗
    - 暴露：逐渐接触"污染"物品
    - 反应预防：延迟或减少洗手
- 认知治疗：挑战过度责任感信念

治疗结果

12 周治疗后，洗手减少到 10 次/天，检查时间减少到 15 分钟/天，恢复全职工作

[高共病率]

- 抑郁障碍：约 2/3 的患者
- 焦虑障碍：76%
- 抽动障碍：30%
- 强迫型人格障碍：23-32%

[相关/易混淆障碍]

- 强迫型人格障碍：特征为完美主义和控制，通常 ego-syntonic
- 疾病焦虑障碍：专注于害怕患病
- 躯体变形障碍：专注于感知到的外貌缺陷
- 囤积障碍：难以丢弃物品
- 拔毛癖（拔毛障碍）和抓痕症（搔抓皮肤）

- 自闭症谱系障碍：可能有重复行为，但社交沟通缺陷是核心

10.性欲倒错

[病名]

性欲倒错

[俗称]

性偏好障碍、异常性偏好

[症状]

核心特征

- 对非典型的性刺激或性对象产生持续、强烈且难以控制的性欲望、性幻想或性行为
- 这些偏好会显著干扰个体的正常社交、职业功能或亲密关系
- 可能伴随躯体或心理层面的不适

具体表现分类

1. 非典型性对象相关
   - 对非人类物体产生性兴趣（如女性内衣、高跟鞋、皮革制品等）
   - 反复通过触摸、嗅闻这些物体获得性兴奋
   - 对特定身体部位过度关注（如足部、头发等），将其作为主要的性刺激来源
2. 性行为方式异常
   - 施虐或受虐相关：通过对他人施加身体疼痛或让自己承受疼痛来获得性快感
   - 暴露癖：在公共场合故意暴露生殖器以引发他人反应
   - 窥阴癖：反复窥视他人隐私场景如洗澡、性行为
   - 摩擦癖：在拥挤场所故意用身体摩擦他人以获得性兴奋
3. 伴随症状
   - 因自身性偏好与社会规范冲突，产生持续的焦虑、抑郁情绪
   - 担心被他人发现而陷入自我否定

- 若涉及侵犯他人权益，可能导致受害者出现恐惧、创伤后应激反应

- 患者自身可能面临法律风险

[具体诊断]

诊断标准（DSM-5 及 ICD-11）
需同时满足以下所有条件：

1. 症状标准
   - 持续存在（通常至少 6 个月）对非典型性刺激、性对象或性行为方式的强烈性欲望、性幻想或性行为

   - 这种偏好是个体获得性兴奋或性满足的主要或唯一途径

2. 功能损害标准
   - 该性偏好已对个体的社会功能造成显著损害（如无法建立稳定伴侣关系、社交回避）

   - 对职业功能造成影响（如因专注于性幻想影响工作效率）

   - 对心理健康造成损害（如持续焦虑、抑郁、自我厌恶）

3. 排除标准
   - 若涉及对他人的侵犯，需确认行为已实施（或反复有实施冲动且无法控制）

   - 并非由其他精神障碍或物质滥用直接引起

   - 排除因文化、宗教或个人价值观差异导致的"非典型性偏好"

[一般治疗方式]

心理治疗（首选方式）
1. 认知行为疗法(CBT)
   - 识别并纠正患者对性偏好的错误认知

   - 结合行为干预（如厌恶疗法、替代行为训练）

   - 逐步减少异常性冲动

2. 社交技能训练
   - 改善人际互动能力

   - 学习建立健康的亲密关系

- 减少因社交回避导致的异常性偏好强化

3. 团体心理治疗
   - 在安全环境中与其他同类患者交流
   - 减少孤独感，增强治疗动力
   - 需注意筛选成员，避免二次伤害

药物治疗（辅助手段）

1. 抗雄激素药物
   - 如醋酸甲羟孕酮、环丙孕酮
   - 降低体内睾酮水平，减少性冲动强度
   - 适用于性冲动强烈且伴随高风险行为的患者
   - 需定期监测激素水平及副作用
2. 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)
   - 如氟西汀、舍曲林
   - 调节大脑内 5-羟色胺水平
   - 缓解焦虑、抑郁情绪，间接降低冲动控制障碍

社会支持与干预

1. 家庭支持
   - 鼓励家人理解疾病的医学属性
   - 提供情感支持，协助监督治疗进展
2. 法律与社会干预
   - 在专业机构监督下接受治疗
   - 通过法律教育帮助认识行为危害性
   - 避免再次违法

[常见误解/谣言/污名化澄清]

误解 1：性欲倒错是"道德败坏""人品差"的表现
解释：

- 性欲倒错是一种需要专业干预的精神健康问题，而非道德层面的过错
- 发病与多种因素相关：
  - 童年期创伤（如虐待、忽视）
  - 大脑神经递质失衡（如 5-羟色胺、多巴胺异常）
  - 早期不良性经验形成强化
- 患者往往难以自主控制自身的性偏好
- 多数患者会因"不符合社会规范"的偏好感到痛苦、自责
- 归为"道德败坏"会加剧羞耻感，导致隐瞒病情、拒绝治疗

误解 2：有性欲倒错的人一定会实施伤害他人的行为
解释：
- 并非所有患者都会侵犯他人
- 部分患者的性偏好仅涉及非生命物体或双方自愿的行为
- 即使有潜在侵犯性偏好的患者，也常因道德约束或法律恐惧仅停留在幻想阶段
- 主动寻求治疗的患者多有改善自身状况、避免伤害他人的意愿
- 过度排斥会导致患者失去获得帮助的机会，反而可能增加极端行为风险

误解 3：性欲倒错无法治疗，患者会终身受其困扰
解释：
- 虽然治疗周期较长，但通过科学综合治疗可显著改善症状
- 规范认知行为疗法可使异常性行为发生率下降 50%以上
- 抗雄激素药物能明显提升冲动控制能力
- 早发现、早治疗能大幅提高预后效果
- 认为"无法治疗"会让患者丧失信心，放弃干预

[典型病例]

病例背景
- 患者男性，32 岁，未婚

- 因"反复窥阴行为 3 年，伴随焦虑、自责 1 年"就诊

病史特点

1. 症状发展
    - 3 年前偶然窥视女性洗澡产生强烈性兴奋
    - 开始反复寻找类似机会，每周 2-3 次
    - 窥视后出现短暂快感，随后自责和恐惧
2. 功能影响
    - 工作业绩下滑，被领导批评
    - 不敢与女性正常交往，社交回避
    - 夜间失眠、白天情绪低落
    - 产生自杀念头

诊断

- 性欲倒错（窥阴癖）
- 伴随中度抑郁发作

治疗方案

1. 认知行为疗法
    - 每周 1 次，共 24 次
    - 错误认知纠正
    - 厌恶疗法（出现幻想时服用苦味剂）
2. 药物治疗
    - 舍曲林 50mg/日改善抑郁情绪及冲动控制
3. 家庭支持计划
    - 与家人定期沟通治疗进展
    - 获得情感支持

治疗效果

- 3 个月后：窥阴冲动频率降至每月 1 次以下

- 6 个月后：抑郁症状缓解，能正常上班，参加社交活动

- 1 年后：未再出现窥阴行为，建立稳定恋爱关系

[高共病率]

1. 冲动控制障碍
   - 如病理性赌博、拔毛癖

   - 共病率约 30%-40%

2. 抑郁障碍
   - 如重度抑郁发作

   - 共病率约 25%-35%

3. 焦虑障碍
   - 如社交焦虑障碍、广泛性焦虑障碍

   - 共病率约 20%-30%

4. 物质使用障碍
   - 如酒精依赖、大麻滥用

   - 共病率约 15%-25%

5. 童年期创伤相关障碍
   - 如创伤后应激障碍(PTSD)

   - 共病率约 10%-20%

[相关/易混淆障碍]

1. 性别烦躁（性别不安）
   - 易混淆点：均可能表现出"与社会常规不符的性别相关行为"

   - 区别：核心是个体对自身生理性别与性别认同的不一致感到痛苦，无异常性偏好

2. 表演型人格障碍
   - 易混淆点：可能通过暴露身体、夸张的性行为表现吸引他人关注

   - 区别：核心是长期、广泛的人格模式异常，暴露行为是"吸引关注"的手段

3. 精神分裂症（伴性相关幻觉妄想）

- 易混淆点：可能在幻觉或妄想支配下出现异常性行为

- 区别：行为由精神病性症状直接引发，患者缺乏自知力

4. 双相情感障碍（躁狂发作）
   - 易混淆点：可能出现性欲亢进、性行为轻率

   - 区别：性行为异常是"情绪高涨、冲动控制下降"的伴随症状，与情绪周期一致

特定恐惧症

[俗称]
特定恐怖症、单一恐惧症

[症状]
特定恐惧症的核心症状是对特定物体、场景或活动产生过度且不合理的恐惧，伴随强烈的焦虑反应和回避行为，具体表现包括：

1. 躯体症状
面对恐惧对象时，会出现心跳加速、呼吸急促、出汗、头晕、恶心、胸闷、肌肉紧张、发抖、手脚冰凉等生理反应，严重时可能诱发惊恐发作（如突发强烈恐惧、濒死感）。

2. 情绪症状
感到极度恐惧、焦虑、不安，明知这种恐惧超出实际危险程度（如害怕一只小蜘蛛、一次电梯乘坐），但无法控制。

3. 行为症状
主动且持续地回避恐惧对象，若无法回避则会极度痛苦、难以忍受，甚至影响正常生活（如因害怕狗而拒绝出门，因害怕封闭空间而放弃乘坐电梯、地铁）。

4. 认知症状
过度高估恐惧对象的危险性（如认为“蜜蜂一定会蛰我，蛰了会致命”），同时低估自己应对恐惧的能力（如“我无法忍受待在黑暗里哪怕一分钟”）。

[具体诊断]

对特定物体或场景（如动物、自然环境、血液/注射、封闭空间等）产生显著且持续的恐惧或焦虑，恐惧程度与实际威胁严重不符；

恐惧对象存在时或预期会接触恐惧对象时，会立即诱发焦虑或恐惧反应；

个体主动回避恐惧对象，或在接触时需忍受强烈的痛苦/焦虑；

这种恐惧、焦虑或回避行为持续至少 6 个月；

恐惧、焦虑或回避行为显著影响个体的日常生活、学业、工作或人际关系（如因害怕飞机而无法参与跨城工作，因害怕抽血而拒绝体检）；

排除其他精神障碍（如惊恐障碍、强迫症、创伤后应激障碍等）或躯体疾病（如甲状腺功能亢进）导致的类似症状。

[一般治疗方式]

1. 心理治疗

暴露疗法：最有效的治疗方式，通过“循序渐进接触恐惧对象”（如害怕蛇的患者，先看蛇的图片→看蛇的视频→隔着玻璃看真实蛇→近距离接触无毒蛇），让身体逐渐适应恐惧刺激，减少焦虑反应。

认知行为疗法（CBT）：结合“认知重构”与“行为训练”，帮助患者识别并纠正“过度高估危险”的不合理认知（如“蜘蛛大多无毒，不会主动攻击人”），同时通过行为练习减少回避。

系统脱敏疗法：通过“放松训练 + 逐级暴露”，让患者在放松状态下接触恐惧对象，逐步降低恐惧与焦虑的关联。

2. 药物治疗

（辅助手段，多用于缓解严重焦虑症状）

苯二氮䓬类药物（如阿普唑仑）：短期使用可快速缓解急性焦虑，但长期使用可能产生依赖性，需严格遵医嘱。

选择性 5- 羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs，如舍曲林、帕罗西汀）：适用于合并抑郁情绪或焦虑症状较严重的患者，需持续服用数周才能起效，不可自行停药。

β 受体阻滞剂（如普萘洛尔）：可减轻心跳加速、手抖等躯体焦虑症状，常用于“预期性焦虑”场景（如害怕演讲的患者在赛前服用）。

3. 其他干预

家庭支持：家人避免嘲笑或强迫患者接触恐惧对象，给予理解与鼓励，配合治疗进程。

自我调节：学习深呼吸、正念冥想等放松技巧，在接触恐惧对象前或焦虑发作时使用，缓解躯体不适。

[常见误解/谣言/污名化澄清]

常见理解 1：“特定恐惧症就是‘胆小’，勇敢一点就能克服”

解释：特定恐惧症不是“胆小”或“意志力薄弱”，而是大脑对“特定刺激”产生的“过度应激反应”——患者明知恐惧不合理，却无法通过“意志力”控制生理与情绪反应（如同哮

喘患者无法靠“憋气”缓解呼吸困难）。强迫患者“勇敢面对”（如把怕狗的人强行拉到狗身边）会加重恐惧创伤，反而导致更严重的回避行为。

常见理解 2：“恐惧的对象都是‘没用的’，比如怕蜘蛛、怕黑暗，不接触就行了”
解释：很多恐惧对象无法完全回避（如怕封闭空间的人需要乘坐电梯、飞机，怕血液的人需要体检、就医），长期回避会逐渐缩小生活范围，影响学业、工作和社交（如因怕高而放弃高层办公楼的工作机会，因怕陌生人而拒绝社交）。且特定恐惧症可能泛化（如怕猫的人逐渐扩展到怕所有毛茸茸的动物），若不干预，症状可能持续数年甚至终身。

常见理解 3：“只有儿童才会有特定恐惧症，长大就好了”
解释：儿童期确实是特定恐惧症的高发期（如怕雷声、怕陌生人），但部分儿童的恐惧不会随年龄消失，反而会持续到成年；也有成年人因创伤事件（如被狗咬伤后怕狗、经历地震后怕封闭空间）诱发特定恐惧症。无论年龄大小，若症状影响生活，都需要专业干预，而非“等待自愈”。

[典型病例]

病例 1：22 岁女性，因“害怕电梯 5 年，影响工作”就诊。患者 5 年前曾被困电梯 10 分钟，此后每次接近电梯就出现心跳加速、手抖，必须由他人陪同乘坐，若电梯内人多则会恐慌发作（头晕、濒死感）。为避免乘电梯，她拒绝所有位于 3 楼以上的工作机会，日常仅选择走楼梯（最高爬 12 楼）。经“暴露疗法 + 认知重构”治疗 8 周后，可独立乘坐电梯，焦虑症状明显减轻。

[高共病率]

惊恐障碍：约 30% 的特定恐惧症患者合并惊恐障碍，因“接触恐惧对象诱发惊恐发作”，进一步加重回避行为；

社交焦虑障碍：害怕“被他人评判”的社交焦虑，可能与特定恐惧症叠加（如怕在公共场合发言的患者，同时怕封闭会议室）；

广泛性焦虑障碍：长期对多个生活领域（如工作、健康）过度担忧，与特定恐惧症的“特定刺激焦虑”形成叠加；

抑郁障碍：长期因恐惧与回避影响生活质量，可能诱发或加重抑郁情绪（如因怕出门而社交隔离，导致情绪低落）。

[相关/易混淆障碍]

惊恐障碍：无明确恐惧对象，惊恐发作可随机发生（如在家中、路上突然发作）；而特定恐惧症的焦虑发作仅与“特定对象/场景”相关（如仅在乘电梯时发作）；

强迫症（OCD）：恐惧源于“强迫思维”（如怕脏是因“担心被污染导致生病”的反复想法），需通过“强迫行为”（如反复洗手）缓解；特定恐惧症的恐惧直接指向“外部对象”（如怕脏是因怕“泥土本身”），无反复的强迫思维；

创伤后应激障碍（PTSD）：恐惧源于“创伤事件记忆”（如经历车祸后怕坐车），同时伴随

闪回、噩梦等创伤相关症状；特定恐惧症的恐惧可能无明确创伤诱因，或仅因“单次轻微刺激”诱发（如第一次看蜘蛛图片就害怕）；

躯体症状障碍：症状以“躯体不适”为主（如反复担心自己有心脏病），无明确的“特定恐惧对象”；特定恐惧症的核心是“对外部对象的恐惧”，躯体症状仅在接触恐惧对象时出现。

[小众疾病分享]

解离性失忆症

[症状]

患者因极度创伤（如暴力侵害、重大事故）突然遗忘关键个人信息（如姓名、职业、家人长相），甚至无法回忆创伤事件本身。可能伴随“漫游行为”（无目的离家出走，清醒后不记得去过哪里）。记忆缺失通常是片段性的（如只忘记某一年），而非全面失忆。

[诊断要点]

需满足：

① 无法回忆重要个人信息（超出普通遗忘范围）

② ② 记忆缺失与创伤事件直接相关

③ ③ 非由脑损伤/酒精中毒等躯体疾病导致。常见于童年性侵幸存者或灾难亲历者。

[治疗方向]

心理治疗（如催眠疗法、眼动脱敏与再加工 EMDR）帮助安全唤起记忆，重建自我认知。避免强行追问创伤细节（可能加重症状），重点稳定患者情绪。

[常见误解解释]

“这是装失忆”

真相：这是大脑的自我保护机制，通过“屏蔽”痛苦记忆避免二次伤害。患者往往比常人更痛苦（连自己是谁都不确定）。

[案例]

40 岁男性，某天醒来忘记自己是谁、家在哪里，身份证显示他曾是工程师。心理咨询后发现他 15 岁时遭性侵，此后多次短暂失忆，此次因工作压力触发全面遗忘。经 EMDR 治疗，逐步恢复记忆并重返职场。

科塔尔综合征

[症状]

患者坚信自己已经死亡（或身体部分消失，如“内脏腐烂了”“大脑不存在”），但仍在正常活动（吃饭/说话）。可能拒绝进食（认为“死人不需要营养”）、拒绝治疗（觉得医生在骗“尸体”）。常伴随抑郁情绪，但核心特征是“对自身存在的否定”。

[诊断要点]

需满足：

① 持续坚信自己死亡/身体消失（非隐喻表达）
② ② 无幻觉/妄想的其他精神障碍证据
③ ③ 导致社会功能严重受损（如拒绝洗澡/社交）。罕见但真实存在。

[治疗方向]
抗抑郁药（如 SSRIs）改善抑郁基础，心理治疗（如认知行为疗法）逐步引导患者重建“活着”的感知。家属需避免否定患者的感受（如“你别胡说”），而是倾听其恐惧背后的情绪（如孤独/无价值感）。

[常见误解解释]
患者并非撒谎，而是大脑处理自我认知的区域严重失调（可能与颞叶/前额叶功能异常相关）。

[案例]
28 岁女性，产后抑郁加重，某天突然坚信自己“心脏和大脑都烂掉了”，拒绝哺乳并试图绝食。住院后通过药物稳定情绪，再经心理治疗重建自我连接，3 个月后恢复基本生活能力。

异手综合征

[症状]
患者的某一侧手（多为左手）突然做出违背意愿的动作（如掐自己脖子、撕衣服、抓食物塞嘴），仿佛被“外星人控制”。患者能感知手在动，但无法主动停止（比如左手正拧开煤气阀，右手拼命去关）。常见于右脑损伤（如中风、肿瘤）后，因左右脑协调功能丧失导致。

[诊断要点]
需满足：
① 一侧肢体（非全身）出现自主对抗动作
② 患者意识清醒但无法控制该肢体
③ 由脑损伤（如卒中、手术）或神经退行性疾病引发。

[治疗方向]
针对原发病治疗（如中风后康复训练），药物（如氯硝西泮）缓解异常动作，物理治疗（约束带/分心任务）减少危险行为。需长期耐心引导患者适应“双手不同步”。

[常见误解解释]
真相：这是脑损伤后的神经功能失调，患者常因无法控制手而恐惧/羞耻（比如左手当众脱裤子）。

[案例]
60 岁男性，中风后右手写字时，左手突然抢笔并揉烂纸张。他愤怒又无奈：“它好像有自己的想法！”经康复训练和药物控制，3 个月后异常动作频率降低。

卡普格拉综合征

[症状]

患者坚信身边的亲密之人（如父母、配偶、孩子）被“外貌一模一样的冒牌货”替换了，但冒牌货的行为逻辑与真人一致（比如冒牌妈妈依然会做饭，但患者觉得“她不是我真正的妈妈”）。常见于精神分裂症、脑损伤（如颞叶病变）或痴呆患者，患者本人意识清晰，但情感上无法与“冒牌货”建立真实连接。

[诊断要点]

需满足：

① 坚信特定熟人是假冒的（非广泛性怀疑所有人）

② 冒牌者的外貌/行为与真人无异

③ 伴随情绪淡漠（如对“冒牌亲人”无亲密感）

④ 排除普通的多疑或妄想障碍。病因可能与大脑识别面孔的“情感通路”（如梭状回）与认知通路（如前额叶）连接异常有关。

[治疗方向]

针对原发病治疗（如精神分裂症用抗精神病药，脑损伤后康复训练），心理治疗（如帮助患者理解“情感识别障碍”的机制）。家属需避免强行反驳，而是用熟悉的生活细节慢慢重建信任。

[常见误解解释]

真相：患者并非故意怀疑，而是大脑处理“熟悉感”的神经回路出了故障——他们能认出外貌，却感受不到情感上的亲近（比如看到配偶却像看到陌生人）。

[案例]

55 岁男性，脑梗后突然坚信妻子是“间谍假扮的”，尽管妻子穿着日常的衣服、说着只有他们知道的私密往事，他仍坚持“她的眼睛不像原来的她”。经抗精神病药（利培酮）和家庭支持治疗，3 个月后妄想逐渐淡化。

克鲁尔-布西综合征

[症状]

患者表现出极度的好奇心（翻垃圾桶/舔陌生物品）、性冲动亢进（对任何性别/年龄对象频繁求欢）、情绪幼稚化（像小孩一样大笑/哭闹），但同时丧失恐惧感（比如伸手摸老虎）、食欲异常（暴食或啃咬非食物）。典型于双侧颞叶（尤其是杏仁核、海马体）受损的患者（如严重外伤、疱疹性脑炎）。

[诊断要点]

需满足：

① 至少 3 项核心表现（性亢进+好奇心过剩+情绪幼稚+无恐惧+过度进食）

② 由颞叶损伤引发

③ 排除其他精神障碍（如躁狂发作）。非常罕见，但症状极具冲击力。

[治疗方向]

针对原发病治疗（如脑炎用抗病毒药，外伤后康复训练），药物（如 SSRIs）抑制性冲动，行为约束（避免患者因无畏行为受伤）。家属需严格管控危险物品（如刀具/清洁剂），并

通过简单指令引导患者适应社会规则。

[常见误解解释]“患者是故意放纵”
真相：这是大脑（杏仁核）和（海马体）功能丧失的结果——他们不是道德败坏，而是无法感知危险与羞耻（比如当众脱裤子的行为源于对身体的认知失调）。

[案例]
32 岁男性，车祸导致双侧颞叶损伤后，突然开始啃咬家具、频繁拥抱陌生人并试图亲吻，对蛇虫毫无惧色。经康复训练和药物控制，6 个月后异常行为部分缓解，但仍保留过度好奇的特点。

身体完整性认同障碍

[症状]
患者强烈觉得自己“某条健康的肢体不属于自己”（如“左腿是多余的”），这种念头持续多年且无法通过说服改变。部分患者会故意自残（如用刀割腿）或寻求非法截肢手术，术后反而感到“完整”。病因可能与大脑对身体地图（感觉运动皮层）的认知错误有关。

[诊断要点]
需满足：
① 长期（通常＞1 年）认为健康肢体“不该存在”
② 伴随强烈痛苦（甚至抑郁/自杀倾向）
③ 非由躯体疾病或精神分裂症导致。极罕见但真实存在，患者往往隐藏症状多年。

[治疗方向]
目前无特效疗法，心理治疗（如帮助患者接纳身体）+ 药物（如抗抑郁药缓解痛苦情绪）。少数国家允许在严格伦理审查下为患者实施截肢（争议极大），更多通过义肢适配或认知行为疗法减轻症状。

[常见误解解释]
患者并非追求残疾，而是大脑将健康肢体“标记”为异物（类似幻肢痛的反向体验），这种痛苦是真实且持久的（比如有人因无法截肢尝试跳楼）。

[案例]
29 岁女性，从 12 岁起就觉得自己的右臂“不属于我”，多次用皮带勒手臂试图让它“消失”。经心理咨询后，她通过穿戴长袖衣物和正念训练缓解焦虑，虽未截肢但学会了与冲动共存。

司汤达综合征

[症状]
患者在接触极高强度的艺术作品（如西斯廷教堂壁画、卢浮宫《蒙娜丽莎》真迹）或自然奇观（如壮丽峡谷）时，突然出现心悸、呼吸急促、头晕目眩，甚至晕厥或幻觉（看到画面动起来）。通常持续数分钟到几小时，脱离环境后缓解。多见于艺术爱好者或敏感人格者。

[诊断要点]

需满足：

① 在接触极致美感刺激后急性发作

② 症状包括心血管反应（心跳＞120 次/分）+ 神经症状（眩晕/幻觉）

③ 排除心脑血管疾病。本质是大脑处理“美”的感官输入时过载。

[治疗方向]

轻症无需特殊治疗（休息后自愈），重症需吸氧/平卧缓解急性症状。预防方法是避免长时间暴露于高强度艺术环境（如分批次欣赏画作），心理疏导帮助患者建立“适度审美”的认知。

[常见误解解释]

患者发作时心率可达危险水平（类似惊恐发作），是大脑奖赏回路（如多巴胺分泌过量）与自主神经系统的失衡反应——美到极致反而成了“刺激源”。

[案例]

45 岁画家，参观梵蒂冈西斯廷教堂时，仰望米开朗基罗的天顶画后突然心慌、耳鸣，扶墙瘫坐在地，10 分钟后才缓过来。此后他改用“短时间观赏+闭眼休息”的方式欣赏艺术品。